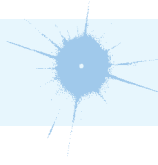


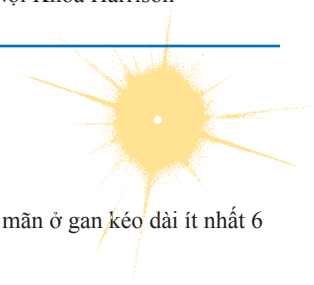
Ở nhiều trung tâm áp lực nội sọ được giám sát - nhạy cảm hơn CT trong phát hiện phù não. Giá trị của dexamethasone vẫn chưa rõ ràng; truyền mannitol có thể có hiệu quả. Ghép gan nên được cân nhắc ở bệnh nhân bệnh lý não độ III -IV và có các yếu tố tiên lượng xấu khác



Đề thảo luận chi tiết hơn, đọc Dienstag JL: Viêm gan virus cấp, Chương 3.04, trang 2537, và Dienstag JL : viêm gan do thuốc và chất độc, chương 305, trang 2558, cuốn “Nguyên Lý Nội Khoa Harrison”

CHƯƠNG 164

Viêm gan mãn tính



Là một rối loạn đặc trưng bởi tình trạng viêm mãn ở gan kéo dài ít nhất 6 tháng

TỔNG QUAN

NGUYÊN NHÂN

Viêm gan virus B (HBV), viêm gan virus C (HCV), viêm gan virus D (HDV delta agent), thuốc (methyldopa, nitrofurantoin, isoniazid, dantrolene), thuốc, viêm gan tự miễn, bệnh Wilson, hemochromatosis, thiếu α_1 -antitrypsin.

PHÂN LOẠI MÔ HỌC

Viêm gan mãn tính có thể phân loại theo mức độ và giai đoạn. Mức độ đánh giá mô hoặc hoạt động viêm và hoại tử dựa trên sinh thiết gan. Giai đoạn viêm gan mãn tính phản ánh mức độ tiến triển của bệnh và dựa trên mức độ xơ hóa (xem Bảng 306-2, p. 2568, HPIM-18).

BIỂU HIỆN

Hình ảnh lâm sàng trải rộng từ không có triệu chứng gì aminotransferase huyết tăng tới các biểu hiện cấp tính, thậm chí viêm gan tối cấp. Các triệu chứng phổ biến gồm mệt mỏi, khó chịu, chán ăn, sốt nhẹ; vàng da thường khi bệnh nặng. Một số bệnh nhân có xuất hiện các biểu chứng xơ gan : cổ trướng, giãn tĩnh mạch chảy máu, bệnh lý não, và lách to. Trong HBV hoặc HCV mãn và viêm gan tự miễn, có thể chủ yếu là các biểu hiện ngoài gan

VIÊM GAN B MÃN TÍNH

Chỉ có khoảng 1-2% trường hợp viêm gan B cấp tính ở người có miễn dịch bình thường; thường ở người suy giảm miễn dịch. Phổ bệnh, không có triệu chứng, viêm gan mãn tính, xơ gan, ung thư biểu mô tế bào gan; giai đoạn sớm thường gắn liền với triệu chứng viêm gan

Tăng aminotransferase, xuất hiện HBeAg và HBV DNA huyết, dạng nhân lên của HBV trong gan; ở giai đoạn muộn hơn ở một số bệnh nhân có thể có cải thiện lâm sàng và hóa sinh, HBeAg và HBV DNA biến mất và xuất hiện anti-HBeAg huyết, và tích hợp HBV DNA vào gen tế bào chủ ở gan. Ở vùng Địa Trung Hải và các quốc gia châu Âu cũng như Châu Á, dạng biến thường gặp biểu hiện là dễ dàng phát hiện HBV DNA, nhưng không có HBeAg (anti- HBeAg- phản ứng). Phần lớn các trường hợp do đột biến vùng pre-C trên gen HBV làm ngăn cản tổng hợp HBeAg (có thể xuất hiện ở trường hợp nhiễm HBV mãn tính type hoang dại do ức chế miễn dịch và có thể giải thích một bài trường hợp viêm gan B tối cấp. Viêm gan B mãn tính cuối cùng dẫn đến xơ gan trong 25-40% trường hợp (chủ yếu ở người bội nhiễm H/dv hoặc đột biến pre-C) và ung thư biểu mô tế bào gan xuất hiện nhiều trong các bệnh nhân này (chủ yếu người mắc khi còn nhỏ)

BIỂU HIỆN NGOÀI GAN (PHÚC HỢP MIỄN DỊCH - TRUNG GIAN)

Phát ban, nổi mề đay, viêm khớp, viêm mạch giống viêm đa động mạch dạng nốt, rối loạn đa thần kinh, viêm cầu thận

ĐIỀU TRỊ

Viêm Gan B Mãn Tính

Có 7 loại thuốc được phê duyệt trong điều trị HBV mãn :interferon α (IFN- α), pegylated interferon (PEG IFN), lamivudine, adefovir dipivoxil, entecavir, telbivudine, and tenofovir (xem [Bảng 164-1](#)). Sử dụng IFN- α dần được thay thế bằng PEG-IFN. [Bảng 164-2](#) tóm tắt các khuyến cáo điều trị HBV mãn tính

VIÊM GAN C MÃN TÍNH

50 -70% trường hợp liên quan đến truyền máu và nhiễm HCV lẻ tẻ. Biểu hiện lâm sàng nhẹ, thường mức độ tăng aminotransferase suy yếu dần; viêm gan mãn tính nhẹ trên sinh thiết gan. Các biểu hiện ngoài gan bao gồm cryoglobuline huyết, rối loạn chuyển hóa porphyria biểu hiện da muộn triệu chứng, viêm cầu thận tăng sinh màng, viêm tuyến nước bọt lympho. Chuẩn đoán xác định bằng phát hiện anti- HCV huyết. Có thể dẫn đến xơ gan trong $\geq 20\%$ sau 20 tuổi.

ĐIỀU TRỊ

Viêm gan C mãn tính

Điều trị nên được cân nhắc ở bệnh nhân phát hiện HCV RNA huyết và bằng chứng sinh thiết gan viêm gan mãn tính mức độ trung bình(xơ vùng quanh tĩnh mạch cửa). Các chất hiện nay được sử dụng điều trị HCV mãn tính, liều lượng và thời gian phụ thuộc vào kiểu gen HCV (Xem [Bảng 164-3](#) và [Bảng 164-4](#)). Bệnh nhân có kiểu gen typ 1, PEG IFN/ ribavirin nên được kết hợp với ức chế protease (boceprevir/ telaprevir) nếu có. Không nên dùng đơn độc ức chế protease do tăng kháng thuốc. Do hiện nay các chất ức chế protease HCV sẵn có chưa được nghiên cứu trên bệnh nhân nhiễm HCV khác các type khác, sử dụng chúng cho các type này chưa được khuyến cáo (xem bảng 164-3)

Bảng 164-1 SO SÁNH ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B^a PEGYLATED INTERFERON (PEG IFN), LAMIVUDINE, ADEFOVIR, ENTECAVIR, TELBIVUDINE, VÀ TENOFOVIR

Đặc điểm	PEG IFN ^b	Lamivudine	Adefovir	Entecavir	Telbivudine	Tenofovir
Đường dùng	tiêm	Đường uống	Uống	uống	Uống	Uống
Thời gian điều trị ^c	48–52 tuần	≥52 tuần	≥48 tuần	≥48 tuần	≥52 tuần	≥48 tuần
Khả năng dung nạp	kém	tốt	tốt, khuyến cáo kiểm soát creatinin	tốt	tốt	tốt, khuyến cáo kiểm soát creatinin
Chuyển đảo huyết thanh						
Dùng 1 năm	18–20%	16–21%	12%	21%	22%	21%
>1 năm	NA	đạt 50% @ 5 năm	43% @ 3 năm ^d	31% @ 2 năm 39% @ 3 năm	30% @ 2 năm	27% @ 2 năm
Giảm Log ₁₀ HBV DNA (nghĩa là copies/mL)						
HBeAg-phản ứng	4.5	5.5	trung bình 3.5–5	6.9	6.4	6.2
HBeAg-âm tính	4.1	4.4–4.7	trung bình 3.5–3.9	5.0	5.2	4.6

(còn nữa)

BẢNG 164-1 SO SÁNH ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B^a PEGYLATED INTERFERON (PEG IFN), LAMIVUDINE, ADEFOVIR, ENTECAVIR, TELBIVUDINE, VÀ TENOFOVIR (TIẾP)

Đặc điểm	PEG IFN ^b	Lamivudine	Adefovir	Entecavir	Telbivudine	Tenofovir
HBV DNA PCR âm tính (<300–400 copi/s/mL; <1000 copies/mL cho adefovir) ở cuối năm 1						
HBsAg-phản ứng	10–25%	36–44%	13–21%	67%(91%@ 4 năm)	60%	76%
HBsAg-âm tính	63%	60–73%	48–77%	90%	88%	93%
ALT bình thường vào cuối năm 1						
HBsAg-phản ứng	39%	41–75%	48–61%	68%	77%	68%
HBsAg-âm tính	34–38%	62–79%	48–77%	78%	74%	76%
HBsAg biến mất năm 1	3–4%	≤1%	0%	2%	<1%	3%
năm 2	12% 5 năm sau 1 yr of Rx	không có dữ liệu	5% vào năm 5	5%	không có dữ liệu	6%
Cải thiện mô học (≥2- giảm 2 điểm trong HAI) vào năm 1						
HBsAg-phản ứng	38% 6 tháng sau	49–62%	53–68%	72%	65%	74%
HBsAg-âm tính	48% 6 tháng sau	61–66%	64%	70%	67%	72%

Kháng virus	không có	15-30% @ 1 năm	không @ 1 năm	$\leq 1\%$ @ 1 năm ^e	5% @ năm 1	0% @ năm 1
		70% @ 5 năm	29% vào 5 năm	1.2% @ 5 năm ^e	22% @ năm 2	0% qua năm 3
Chi phí (US \$) cho 1 năm	~\$18,000	~\$2500	~\$6500	~\$8700 ^f	~\$6000	~\$6000

^a Nói chung, những so sánh này dựa trên mỗi thử nghiệm lâm sàng riêng biệt so với các thuốc giả dược (placebo) trong các thử nghiệm lâm sàng được đăng ký; trong các trường hợp ngoại lệ hiếm gặp, những so sánh này không dựa trên các thử nghiệm các thuốc này từ đầu, các ưu điểm và nhược điểm nên được giải thích cẩn thận

^b Mặc dù IFN- α dùng hằng ngày hoặc 3 lần một được được phê duyệt trong điều trị viêm gan B, nó đã dần được thay thế bằng PEG IFN, nó được dùng một lần một tuần và hiệu quả hơn. IFN tiêu chuẩn không có ưu điểm hơn PEG IFN.

^c Thời gian điều trị trong các thử nghiệm lâm sàng hiệu quả; sử dụng trong thực hành lâm sàng có thể thay đổi

^d Do lỗi ngẫu nhiên do máy tính tạo ra do sự phân bố không đều của các thuốc giả dược trong suốt năm thứ hai của điều trị lâm sàng thử nghiệm, tần số chuyển đổi huyết thanh HBeAg vượt xa trong năm đầu tiên, ước tính (phân tích (kaplan-Meier analysis) dựa trên các tập con nhỏ của adefovir được thực hiện chính xác

^e 7% trong suốt một năm điều trị (43% vào năm 4) ở các bệnh nhân kháng lamivudine

^f ~17,400 bệnh nhân khó điều trị lamivudine

AViết tắt: ALT, alanine aminotransferase; HAI, chỉ số hoạt động mô học; HBeAg, kháng nguyên e; HBsAg, kháng nguyên bề mặt; HBV, viêm gan virus B; NA, không dùng; PEG IFN, pegylated interferon; PCR, polymerase chain reaction; Rx, điều trị; yr, năm.

BẢNG 164-2 KHUYẾN CÁO ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B^a RE MÃN TÍNH

HBeAg	Lâm sàng	HBV DNA (IU/mL)	ALT	Khuyến cáo
HBeAg-phản ứng		$>2 \times 10^4$	$\leq 2 \times \text{ULN}^d$	không điều trị, theo dõi. Ở bệnh nhân >40 , tiền sử gia đình ung thư biểu mô tế bào gan và hoặc ALT tăng gấp đôi giới hạn cao nhất bình thường, sinh thiết gan quyết định điều trị
	Viêm gan mãn tính	$>2 \times 10^4^d$	$>2 \times \text{ULN}^d$	Điều trị ^e
	Xơ gan còn bù	$>2 \times 10^3$	$<$ hoặc $> \text{ULN}$	Điều trị ^e thuốc đường uống không
		$<2 \times 10^3$	$> \text{ULN}$	Cân nhắc điều trị ^f
	Xơ gan mất bù	Có thể phát hiện	$<$ hoặc $> \text{ULN}$	Điều trị ^e thuốc uống ^g , không PEG IFN; tham khảo ghép gan
		Không thể phát hiện	$<$ hoặc $> \text{ULN}$	Quan sát; tham khảo ghép gan
HBeAg-âm tính ^b		$\leq 2 \times 10^3$	$\leq \text{ULN}$	Người mang thể không hoạt động; điều trị không cần thiết
	Viêm gan mãn tính	$>10^3$	$1 \rightarrow 2 \times \text{ULN}^d$	Cân nhắc sinh thiết gan; Điều trị ^h if nếu sinh thiết chỉ ra mức độ viêm trung bình hoặc nặng
	Viêm gan mãn tính	$>10^4$	$>2 \times \text{ULN}^d$	Điều trị ^{h,i}

Xơ gan còn bù	$>2 \times 10^3$	< hoặc > ULN	Điều trị ^e thuốc đường uống không
	$<2 \times 10^3$	>ULN	Cân nhắc điều trị ^f
Xơ gan mất bù	Có thể phát hiện được	< hoặc > ULN	Điều trị ^g w thuốc uống ^g , không PEG IFN; tham khảo ghép gan
	Không thể phát hiện được	< hoặc > ULN	Quan sát; tham khảo ghép gan

Dựa trên hướng dẫn hội nghiên cứu bệnh gan của Mỹ (AASLD). Trừ phần chú thích, các hướng dẫn tương tự như các hướng dẫn của hội nghiên cứu bệnh gan Châu Âu (EASL)

^b Bệnh gan có xu hướng nhẹ hoặc không hoạt động trên lâm sàng, phần lớn các bệnh nhân này không cần sinh thiết gan

^c Mô hình phổ biến trong suốt thập liên đầu ở bệnh nhân Châu Á nhiễm từ lúc mới sinh

^d Theo hướng dẫn của EASL điều trị nếu HBV DNA $>2 \times 10^3$ IU/mL và ALT >ULN.

^e Một trong các thuốc đường uống mạch có hàng rào dễ kháng cáo (entecavir hoặc tenofovir) hoặc PEG IFN có thể được sử dụng như một liệu pháp đầu tiên (xem văn bản). Những loại thuốc uống, không pải PEG IFN, nên được sử dụng ở bệnh nhân kém dung nạp và suy giảm miễn dịch/ IFN- khó điều trị. PEG IFN được tiêm hằng tuần bằng SC trong 1 năm. Các thuốc uống dùng hằng ngày trong ít nhất một năm, hoặc tiếp tục suốt đời hoặc ít nhất 6 tháng sau chuyển đổi HBeAg. Theo hướng dẫn của EASL, bệnh nhân xơ gan mất bù và có thể phát hiện HBV DNA ở bất kì mức độ nào, thậm chí ALT bình thường, đều nên điều trị. Phần lớn, các tác giả cho rằng nên điều trị vĩnh viễn, thậm trí trong trường hợp HBeAg- dương tính sau chuyển đổi huyết thanh HBeAg

^f— Do kháng thuốc làm mất khả năng chống virus và xơ gan mất bù trở lên xấu hơn, phác đồ điều trị ít kháng thuốc được khuyến cáo là entecavir hoặc tenofovir đơn điều trị hoặc phối hợp với các thuốc để kháng thuốc lamivudine (hoặc telbivudine) cộng adefovir. Điều trị nên được tiến hành khẩn trương.

^g Do chuyển đổi huyết thanh HBeAg không phải là một lựa chọn, mục tiêu điều trị là loại bỏ HBV DNA và duy trì ALT bình thường. PEG IFN tiêm mỗi tuần trong một năm, thân trọng, tùy thuộc vào sau điều trị 6 tháng để xác nhận đáp ứng bền vững, vì phần lớn các đáp ứng thường mất đi sau đó. Các thuốc uống enteca-vir hoặc tenofovir, dùng hằng ngày thường suốt đời, tận khi có đáp ứng sinh hóa và virus rất hiếm xuất hiện và kèm theo có chuyển đổi huyết thanh. Bệnh nhân lớn tuổi và xơ gan tiến triển, cân nhắc hạ ngưỡng HBV DNA để $>2 \times 10^3$ IU/mL.

Viết tắt: ALT, alanine aminotransferase; AASLD : hội nghiên cứu bệnh gan Mỹ; EASL, Hội nghiên cứu về gan Châu Âu; HBeAg, Kháng nguyên e; HBsAg, kháng nguyên bề mặt; HBV, virus viêm gan B; PEG IFN, pegylated interferon; ULN, giới hạn trên bình thường.

BẢNG 164-3 PEGYLATED INTERFERON α -2A VÀ α -2B TRONG VIÊM GAN C MIỄN TÍNH

	PEG IFN α -2b	PEG IFN α -2a
kích thước PEG	12 kDa thẳng	40 kDa nhánh
Thời gian bán thải	54 h	65 h
Độ thanh thải	725 mL/h	60 mL/h
Liều	1.5 μ g/kg (dựa-cân nặng)	180 μ g
Bảo quản	nhiệt độ phòng	Tủ lạnh
Ribavirin liều		
Genotype 1	800–1400 mg ^a	1000–1200 mg ^b
Genotype 2/3	800 mg	800 mg
Thời gian điều trị		
Genotype 1 ^c	48 tuần	48 tuần
Genotype 2/3	48 tuần ^d	24 tuần
Hiệu quả điều trị kết hợp ^e	54%	56%
Genotype 1 ^c	40–42%	41–51%
Genotype 2/3	82%	76–78%

^aTrong các thử nghiệm PEG IFN α -2b với ribavirin, phác đồ tối ưu là 1.5 μ g PEG IFN với 800 mg ribavirin; tuy nhiên các phân tích sau nghiên cứu chỉ ra rằng liều ribavirin cao hơn thì tốt hơn. Trong các thử nghiệm tiếp theo PEG IFN α -2b với ribavirin ở bệnh nhân genotype 1, liều ribavirin hằng ngày sau đã được kiểm định: 800 mg với bệnh nhân <65 kg, 1000 mg với bệnh nhân >65–85 kg, 1200 mg với bệnh nhân >85–105 kg, and 1400 mg với bệnh nhân >105 kg.

^b1000 mg bệnh nhân <75 kg; 1200 mg bệnh nhân $\geq$ 75 kg.

^cDựa trên phác đồ PEG IFN/ribavirin không kháng protease

^dTrong các thử nghiệm PEG IFN α -2b với ribavirin, tất cả bệnh nhân được điều trị trong 48 h; tuy nhiên dữ liệu từ các thử nghiệm khác về IFNs tiêu chuẩn và PEG IFN chứng minh rằng 34 tuần là đủ cho bệnh nhân genotypes 2 và 3. Đối bệnh nhân genotype 3, xơ gan tiến triển/ xơ gan và/ hoặc HCV RNA cao, điều trị đủ 48 tuần

^eNhững lỗ hổng so sánh 2 chế phẩm PEG IFN dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng bị làm sai do sự khác nhau của 2 thử nghiệm về phương pháp chi tiết (liều ribavirin khác nhau, khác nhau về phương pháp ghi đáp ứng, và các tác dụng phụ) và nghiên cứu thành phần dân số (tỉ lệ khác nhau cầu xơ (bridging fibrosis)/ xơ gan, tỉ lệ Hoa kì so với quốc tế, cân nặng trung bình, tỉ lệ genotype 1, và tỉ lệ HCV RNA cao). Trong so sánh từ đầu hai chế phẩm PEG IFN trong thử nghiệm IDEAL được báo cáo trong 2009, 2 chế phẩm được so sánh về khả năng dung nạp và hiệu quả. PEG IFN α -2b dùng hằng tuần liều phụ thuộc cân nặng 1.0 μ g/kg hoặc 1.5 μ g/kg, và PEG IFN α -2a dùng hằng tuần với liều cố định 180 μ g. Trong PEG IFN α -2b, ribavirin dùng hằng ngày liều phụ thuộc cân nặng giới hạn từ 800–1400 mg dựa trên các tiêu chí cân nặng;^a trong khi PEG IFN α -2a, ribavirin dùng hằng ngày liều phụ thuộc cân nặng giới hạn từ 1000 và 1200 mg.^bTrong nhóm nghiên cứu PEG IFN α -2b, giảm liều ribavirin trong các trường hợp phản ứng có hại liên quan đến ribavirin giảm từ 200- đến 400-mg; trong PEG IFN α -2a, liều ribavirin giảm xuống 600 mg vì không dung nạp

Đáp ứng virus bền vững xuất hiện 38.0% liều thấp nhóm PEG IFN α -2b; 39.8% liều chuẩn, liều đầy đủ nhóm PEG IFN α -2b; và 40.9% nhóm PEG IFN α -2a. Viết tắt: PEG, polyethylene glycol; PEG IFN, pegylated interferon; HCV RNA, RNA virus viêm gan C.

BẢNG 164-4 CHỈ ĐỊNH VÀ KHUYẾN CÁO TRONG ĐIỀU TRỊ KHÁNG VIRUS VIÊM GAN C

Điều trị tiêu chuẩn

Phát hiện HCV RNA (kèm hoặc không ALT)

Xơ gan mức độ trung bình đến nặng trên sinh thiết gan

Khuyến cáo điều trị lại

Genotype 1 Tái phát, đáp ứng một phần, hoặc không đáp ứng sau một đợt điều trị IFN chuẩn đơn trị liệu hoặc kết hợp IFN chuẩn/ ribavirin hoặc PEG IFN/ ribavirin

Một đợt dùng PEG-IFN/ribavirin với kháng protease và như sau

Genotype 2, 3, 4

Tái phát sau đơn trị liệu IFN tiêu chuẩn hoặc kết hợp IFN tiêu chuẩn/ ribavirin

Điều trị một đợt IFN PEG với ribavirin

Không đáp ứng với điều trị IFN tiêu chuẩn đơn trị liệu hoặc kết hợp IFN tiêu chuẩn ribavirin

Một đợt điều trị PEG IFN với ribavirin—nhiều khả năng đã đạt được đáp ứng bền vững với virus ở bệnh nhân da trắng không có điều trị ribavirin trước đó, nồng độ HCV RNA nền thấp, kèm giảm 2- $\log_{10}$ HCV RNA trong suốt điều trị trước, với genotypes 2 and 3, và không kèm giảm liều ribavirin

Quyết định điều trị kháng virus trên cơ sở cá nhân

Trẻ em (tuổi <18)—kháng protease không được khuyến

cáo ở độ tuổi >60

Viêm gan nhẹ trên sinh thiết

Bệnh nhân có suy thận nặng

Khuyến cáo điều trị kéo dài

Viêm mạch Cryoglobulin huyết kèm viêm gan C mãn tính

Điều trị kéo dài ở nhóm không đáp ứng không được khuyến cáo

Điều trị kháng virus không được khuyến cáo

Xơ gan mất bù

Mang thai (gây quái thai ribavirin)

Chống chỉ định với thuốc

Phác đồ điều trị

HCV genotype 1

PEG IFN- α 2a 180 μ g mỗi tuần với ribavirin 1000 mg/d (cân nặng <75 kg) to 1200 mg/d (cân nặng $\geq$ 75 kg) hoặc

PEG IFN- α 2b 1.5 μ g/kg mỗi tuần với ribavirin 800 mg/d (Liều được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng nhưng liều ribavirin phụ thuộc cân nặng được khuyến cáo cho cả 2 type PEG IFN)

(còn nữa)

BẢNG 164-4 CHỈ ĐỊNH VÀ ĐIỀU TRỊ KHÁNG VIRUS Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN C MẠN TÍNH

Phác đồ điều trị

Cộng với một chất kháng protease bao gồm một trong hai thuốc sau:

Boceprevir 800 mg 3 lần mỗi ngày bắt đầu sau điều trị 4 tuần với PEG IFN/ribavirin

- Bệnh nhân không phát hiện HCV RNA vào 8 và 24 tuần nên được nhận điều trị kết hợp 3 thuốc (PEG-IFN/ribavirin, boceprevir) 28 tuần. Nếu phát hiện HCV RNA ở tuần thứ 4, tiếp tục điều trị 48 tuần (4 tuần PEG IFN/ ribavirin sau đó 44 tuần kết hợp 3 thuốc) có thể làm tăng tỉ lệ kháng thuốc
- Bệnh nhân phát hiện HCV RNA ở tuần thứ 8, và không phát hiện ở tuần thứ 24 nên phối hợp điều trị 3 thuốc (PEG-IFN/ribavirin, boceprevir) trong 36 tuần (4 tuần PEG IFN/ ribavirin sau đó 32 tuần kết hợp 3 thuốc) sau đó lặp lại PEG IFN/ribavirin trong hơn 12 tuần, tổng thời gian điều trị 48 tuần
- Bệnh nhân xơ gan điều trị mới và không phát hiện HCV RNA tuần 8 và 24 nên kết hợp 3 thuốc (PEG IFN/ribavirin, boceprevir) trong 48 tuần (4 tuần PEG IFN/ ribavirin sau đó 44 tuần kết hợp 3 thuốc)

Telaprevir 750 mg 3 lần mỗi ngày bắt đầu điều trị không kèm PEG IFN/ ribavirin

- Bệnh nhân không phát hiện HCV RNA vào tuần 4 và 12 nên điều trị phối hợp 3 thuốc (PEG IFN/ribavirin, telaprevir) trong 12 tuần sau đó PEG-IFN và ribavirin trong 12 tuần nữa, tổng cộng 24 tuần
- Bệnh nhân xơ gan mới điều trị không phát hiện HCV RNA ở tuần 4 và 12 nên nhận điều trị phối hợp 3 thuốc trong 12 tuần sau đó PEG-FN, ribavirin trong 36 tuần nữa, tổng cộng 48 tuần

HCV genotype 1 ở nơi không sẵn kháng protease hoặc có chống chỉ định - điều trị trong 48 tuần

PEG IFN- α 2a 180 μ g hằng tuần với ribavirin 1000 mg/d (cân nặng <75 kg) tới 1200 mg/d (cân nặng $\geq$ 75 kg) hoặc

PEG IFN- α 2b 1.5 μ g/kg hằng tuần với ribavirin 800 mg/d (liều được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng, nhưng cao hơn, liều ribavirin theo cân nặng trên được khuyến cáo cho cả 2 type PEG IFN)

HCV genotype 4— điều trị 48 tuần

PEG IFN- α 2a 180 μ g hằng tuần với ribavirin 1000 mg/d (cân nặng <75 kg) tới 1200 mg/d (cân nặng $\geq$ 75 kg) hoặc

PEG IFN- α 2b 1.5 μ g/kg hằng tuần với ribavirin 800 mg/d (liều được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng, nhưng cao hơn, liều ribavirin theo cân nặng trên được khuyến cáo cho cả 2 type PEG IFN)

- Nên ngừng điều trị ở bệnh nhân không đạt đáp ứng virus sớm ở tuần thứ 12

BẢNG 164-4 CHỈ ĐỊNH VÀ KHUYẾN CÁO DÙNG KHÁNG VIRUS Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN C MẠN TÍNH

Phác đồ điều trị

- Bệnh nhân đạt đáp ứng virus sớm nên được kiểm tra lại ở tuần 24 và nên ngừng điều trị nếu HCV RNA vẫn dương tính

HCV genotypes 2 và điều trị 3–24 tuần

PEG IFN- α 2a 180 μ g mỗi tuần với ribavirin 800 mg/d hoặc

PEG IFN- α 2b 1.5 μ g/kg mỗi tuần với ribavirin 800 mg/d (ở bệnh nhân genotype 3 xơ gan tiến triển và/ hoặc mức HCV RNA cao, nên điều trị đầy đủ 48 tuần)

Đối với bệnh nhân nhiễm đồng thời HCV-HIV : 48 tuần, bất kỳ kiểu gen nào, điều trị hằng tuần PEG IFN- α 2a (180 μ g) và PEG IFN- α 2b (1.5 μ g/kg) với liều ribavirin hằng ngày ít nhất 600–800 mg, hay phụ thuộc vào cân nặng 1000- to 1200-mg nếu dung nạp được. Kháng protease genotype I không được khuyến cáo trong quần thể này hiện nay do có khả năng tương tác với các thuốc kháng HIV

Các đặc điểm liên quan đến giảm đáp ứng

Single-nucleotide polymorphism (SNP) T allele (trái với C allele) ở IL28B locus Genotype 1

Mức độ HCV RNA cao (>2 million copies/mL hoặc >800,000 IU/mL)

Xơ gan tiến triển

Bệnh kéo dài

Tuổi >40

Chủng biến đổi HCV cao

Suy giảm miễn dịch

Người Mỹ gốc Phi

Dân tộc Latino

Béo phì

Gan nhiễm mỡ

Kháng insulin, đái tháo đường type II

Không tuân thủ điều trị (giảm liều thuốc và giảm thời gian điều trị)

Viết tắt: ALT, alanine aminotransferase; HCV, virus viêm gan C; IFN, interferon; PEG IFN, pegylated interferon; IU, đơn vị quốc tế (1 IU/mL tương đương với ~2.5 copies/mL).

Giám sát HCV RNA huyết hữu ích trong đánh giá đáp ứng điều trị. Mục đích điều trị là loại bỏ HCV RNA, tiền lượng bằng không xuất hiện HCV RNA bằng phản ứng chuỗi polymerase 6 tháng sau ngừng điều trị ("đáp ứng virus duy trì"). Điều trị thất bại khi giảm 2-log HCV RNA vào tuần 12 của điều trị

không chắn chắn liệu pháp khác sẽ mang lại kết quả đáp ứng virus bền vững. Do đó, khuyến cáo kiểm tra HCV RNA ở tuần 4, 12 và 24 để đánh giá điều trị và hỗ trợ trong thời gian sau điều trị sau 12 tuần. Bệnh nhân genotype I nhận boceprevir nên kiểm tra HCV RNA thêm ở tuần 8, điều này có thể ảnh hưởng đến thời gian điều trị. Các ý kiến hiện nay đồng thuận rằng điều trị có thể chấm dứt nếu không đạt được đáp ứng virus sớm

VIÊM GAN A

Mặc dù viêm gan A hiếm khi gây viêm gan tối cấp, thường gặp hơn ở bệnh nhân bệnh gan mãn tính - đặc biệt viêm gan B hoặc C. Vaccine viêm gan A kích thích miễn dịch và dung nạp tổ ở bệnh nhân viêm gan mãn tính. Do đó bệnh nhân bệnh gan mãn, đặc biệt viêm gan B hoặc C nên tiêm vaccine phòng viêm gan A

VIÊM GAN TỰ MIỄN

PHÂN LOẠI

Type I: Phân loại viêm gan tự miễn, kháng thể kháng tế bào cơ trơn và/ hoặc kháng thể kháng nhân (ANA). Type II: liên quan đến kháng thể kháng microsomal ở thận/gan (anti-LKM) chúng kháng trực tiếp cytochrome P450IID6 (chủ yếu gặp ở miền Nam châu Âu). Type III bệnh nhân thiếu ANA và anti-LKM, phản ứng kháng thể với cytokeratin tế bào gan, lâm sàng giống type I. Tiêu chuẩn chuẩn đoán được đề xuất bởi các tổ chức quốc tế.

BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

Phân loại viêm gan tự miễn (type I): 80% phụ nữ, trong thập kỉ thứ 3 đến thứ 5. Khởi phát đột ngột (viêm gan cấp) chiếm 1/3, diễn biến âm thầm 2/3 : vàng da tiến triển, chán ăn, gan to, đau bụng, chảy máu cam, sốt, mệt mỏi, mất kinh. Dẫn tới xơ gan; >50% chết sau 5 năm nếu không được điều trị.

BIỂU HIỆN NGOÀI GAN

Phát ban, đau khớp, khô mắt, viêm tuyến giáp, thiếu máu tan huyết, viêm thận

BẤT THƯỜNG HUYẾT THANH

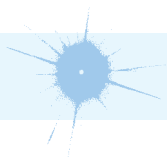
Tăng gamma globuline huyết, yếu tố dạng thấp dương tính, kháng thể kháng cơ trơn (40–80%), ANA (20–50%), kháng thể kháng ty nạp thể (10–20%), anti-HCV enzym miễn dịch dương tính giả, nhưng thường không HCV RNA, p-ANCA không điều hình. Type II: Kháng thể kháng -LKM.

Điều trị

Viêm gan tự miễn

Chỉ định khi có triệu chứng, sinh thiết gan viêm gan mãn tính nghiêm trọng (hoại tử cầu nối), aminotranferase tăng đáng kể (gấp 5 - 10 lần), và tăng gamma globuline huyết. Prednisone hoặc prednisolone 30 -60 mg/ ngày uống giảm liều tới 10 -15 mg/ngày trong một vài tuần; thường azathioprine 50mg/ ngày uống cũng được cho phép với liệu glucocorticoid và tránh các tác dụng phụ của steroid

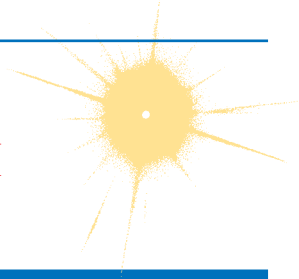
Theo dõi xét nghiệm chức năng gan hằng tháng. Các triệu chứng có thể cải thiện nhanh, nhưng cải thiện sinh hóa ó thể mất vài tuần hoặc vài tháng tiếp theo cải thiện mô học (tổn thương viêm gan mãn tính nhẹ, hoặc sinh thiết bình thường) mất 18-24 tháng. Nên điều trị liên tục trong ít nhất 12 -18 tháng. Tái phát xuất hiện ít nhất 50% các trường hợp (tái điều trị). Trong các trường hợp tái phát, cân nhắc điều trị duy trì với liều glucocorticoid thấp hoặc azathioprim 2 (mg/kg)/ ngày



Đề thảo luận chi tiết hơn, đọc Dienstag JL, viêm gan mãn tính, Chương 305, trang 2567, cuốn “Nguyên Lí Nội Khoa Harrison”

CHƯƠNG 165

XƠ GAN VÀ BỆNH GAN DO RƯỢU



XƠ GAN

Xơ gan được xác định trên mô học và có nhiều nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, và biến chứng. Trong xơ gan, tiến triển xơ, biến dạng cấu trúc gan cùng với hình thành các nốt tái tạo, dẫn đến làm giảm chức năng gan

NGUYÊN NHÂN (XEM BẢNG 165-1)

BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

Có thể không có biểu hiện, phát hiện tình cờ trong phẫu thuật

BẢNG 165 -1 NGUYÊN NHÂN XƠ GAN

Nghiện rượu	Xơ gan tim
Viêm gan virus mãn tính	Bệnh gan chuyển hóa di truyền
Viêm gan B	Ứ sắt
Viêm gan	Bệnh Wilson
Viêm gan tự miễn	thiếu α_1 -Antitrypsin
Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu	Xơ nang
Xơ gan mật	Xơ gan chưa rõ nguyên nhân
Xơ gan mật nguyên phát	
Viêm xơ đường mật nguyên phát	
Bệnh đường mật tự miễn	

Triệu chứng

Chán ăn, buồn nôn, nôn, ỉa chảy, đau âm ỉ hạ sườn phải, mệt mỏi, suy nhược, vàng da, vô kinh, liệt dương, vô sinh

Dấu hiệu

Sao mạch (nốt nhện), lòng bàn tay son, vàng da, cứng mạc vàng, phì đại tuyến lệ và tuyến mang tai, ngón tay dài trắng, cơ thất Dupuytren, vú to nam giới, teo tinh hoàn, gan lách to, cổ trướng, chảy máu đường tiêu hóa (do giãn mạch), bệnh lý não gan

Xét Nghiệm

Thiếu máu (hồng cầu nhỏ do mất máu, hồng cầu to do thiếu acid folate; tan máu hội chứng Zieve), giảm tiểu cầu (tăng hoạt động của lách), PT kéo dài, hiếm DIC rõ; giảm Natri máu, nhiễm kiềm hạ kali máu, rối loạn glucose, giảm albumin máu.

NGHIÊN CỨU CHUẨN ĐOÁN

HBsAg. Phụ thuộc vào bối cảnh lâm sàng. Huyết thanh: HBsAg,, anti-HBc, anti-HBs, anti-HCV, anti-HDV, Fe, tổng dự trữ sắt, ferritin, kháng thể kháng ty nập thể (AMA), kháng thể kháng cơ trơn (SMA), kháng thể kháng vi nập thể ở gan. thận (anti-LKM), ANA, ceruloplasmin, α_1 antitrypsin (và kiểu hình); siêu âm thường với siêu âm doppler bụng, CT hoặc MRI (có thể cho thấy xơ gan, lách to, tuần hoàn bàng hệ, huyết khối tĩnh mạch). Xác định chuẩn đoán thường dựa vào sinh thiết gan (qua da, qua tĩnh mạch cảnh, hoặc mở bụng)

BIẾN CHỨNG (XEM BẢNG 165-2 VÀ CHƯƠNG. 48, 49, VÀ 166)

Thang điểm Child-pugh được sử dụng để tiên lượng mức độ nghiêm trọng của xơ gan và nguy cơ biến chứng (BẢNG 165-3).

BẢNG 165-2 BIẾN CHỨNG XƠ GAN	
Tăng áp lực tĩnh mạch cửa	Rối loạn đông máu
Dãn tĩnh mạch dạ dày thực quản	Thiếu yếu tố
Bệnh lý dạ dày do tăng áp lực tĩnh mạch cửa	Huyết fibrin
Lách to, tăng hoạt lách	Giảm tiểu cầu
Cổ trướng	Bệnh lý xương
Nhiễm khuẩn phúc mạc tự phát	Giảm mật độ xương
Hội chứng gan thận	Loãng xương
Type 1	Nhuuyễn xương
Type 2	Bất thường huyết học
Bệnh lý não gan	Thiếu máu
Hội chứng gan phổi	Tán huyết
Tăng áp phổi cửa	Giảm tiểu cầu
Suy dinh dưỡng	Giảm bạch cầu trung tính

BẢNG 165-3 PHÂN LOẠI XƠ GAN THEO CHILD- PUGD

Yếu tố	Units	1	2	3
bilirubin huyết	μmol/L	<34	34–51	>51
	mg/dL	<2.0	2.0–3.0	>3.0
albumin huyết	g/L	>35	30–35	<30
	g/dL	>3.5	3.0–3.5	<3.0
thời gian Prothrombin	Giây	0–4	4–6	>6
	Kéo dài			
	INR	<1.7	1.7–2.3	>2.3
Cổ trướng		Không	Dễ kiểm soát	Khó kiểm soát
Bệnh lý não gan		Không	Nhẹ	Tiến triển

Chú ý: Than điểm Child- Pugh được tính bằng tổng 5 yếu tố và dao động từ 5-15. Phân loại Child- pugh A (5-6 điểm), B (7-9 điểm) hoặc C (10 hoặc trên). Xơ gan mất bù điểm Child-Pugh từ 7 điểm (phân loại B). Xơ gan ở mức độ này được chấp nhận cho cấy ghép gan

BỆNH GAN DO RƯỢU

Sử dụng quá nhiều rượu ó thể gây gan nhiễm mỡ, viêm gan rượu, xơ gan. Xơ gan rượu chiếm trên 40% nguyên nhân tử vong do sơ gan. Thường có tiền sử sử dùng rượu quá nhiều. Tình trạng nghiêm trọng (viêm gan, xơ gan) liên quan đến dùng 160g/ ngày trong 10 -20 năm; phụ thường dễ mắc hơn nam giới và tiến triển thành bệnh gan nặng dù uống ít hơn nam giới. Viêm gan B và C có thể đồng thời làm tiến triển nặng hơn. Suy dinh dưỡng cũng góp phần làm tiến triển xơ gan.

GAN NHIỄM MỠ

Thường xuất hiện gan to không triệu chứng và tăng nhẹ test hóa sinh gan. Trở về bình thường nếu ngừng ethanol; không dẫn đến xơ gan

VIÊM GAN RƯỢU

Biểu hiện lâm sàng từ không có triệu chứng gì tới suy gan nặng kèm vàng da, cổ chướng, chảy máu đường tiêu hóa và bệnh lý não gan. Diễn hình chán ăn, buồn nôn, nôn, sốt, vàng da, gan to ấn đau. Đôi khi hình ảnh ứ mật giống như tắc mật. Aspartate aminotransferase (AST) thường <400 U/L và gấp hơn 2 lần so với alanine aminotransfer-ase (ALT). Bilirubin và bạch cầu có thể tăng. Chuẩn đoán xác định bằng sinh thiết gan: tế bào gan phồng, thể trong do rượu (thể Mallory), thâm nhiễm PMN, tế bào gan hoại tử, xơ hóa quanh tĩnh mạch trung tâm

CÁC HẬU QUẢ CHUYÊN HÓA KHÁC CỦA NGHIỆN RƯỢU

Tăng tỉ lệ NADH/NAD dẫn đến toan chuyển hóa, nhiễm toan keton, tăng uric máu, hạ đường huyết, giảm magie máu, giảm phosphat máu. Rối loạn chức năng của ty nạp thể, cảm ứng enzym vi thể làm thay đổi chuyển hóa thuốc

peroxy hóa lipid làm tổn thương màng, tình trạng tăng chuyển hóa; nhiều triệu chứng của viêm gan rượu được quy cho là ảnh hưởng của các chất độc acetaldehyde và cytokine (interleukin 1 và 6, và TNF, được giải phóng do suy giảm chức năng thải chất độc của gan)

CÁC YẾU TỐ TIỀN LƯỢNG BẤT LỢI

Tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân nặng trong 30 ngày. Viêm gan nặng do rượu có biểu hiện $PT > 5 \times PT$ chứng, bilirubin $> 137 \mu\text{mol/L}$ ($> 8 \text{ mg/dL}$), giảm albumin máu, tăng ure huyết. Chỉ số DF (discriminant function) $= 4.6 \times (PT \text{ bệnh} - PT \text{ chứng}) + \text{bilirubin huyết (mg/dL)}$. $DF \geq 32$ tiên lượng nặng. Cổ trướng, xuất huyết gian mạch, bệnh lý não gan, hội chứng gan thận tiên lượng xấu

ĐIỀU TRỊ

Bệnh Gan Do Rượu

Chế độ ăn tiết chế là cần thiết; 8500- tới 12,500-kJ (2000- đến 3000-kcal) 1 g/kg protein (ít hơn nếu có bệnh lý gan). Hằng ngày, chế độ ăn giàu vitamin, thiamine 100 mg, folic acid 1 mg. Kali, magie vừa đủ, và thiếu phosphate. Truyền hồng cầu lắng, huyết tương nếu cần thiết. Theo dõi đường huyết (hạ đường huyết trong bệnh gan nặng). Prednisone 40 mg/ngày hoặc prednisolone 32 mg/ ngày uống trong một tháng có thể hữu ích trong trường hợp viêm gan rượu nặng kèm bệnh não gan (trừ chảy máu đường tiêu hóa, suy thận mãn, nhiễm trùng). Pentoxifylline được chứng minh cải thiện thời gian sống và là được chất thay thế glucocorticoid trong điều trị viêm gan viêm gan do rượu nặng. Ghép gan có thể là lựa chọn cho các bệnh nhân xơ gan đã thực hiện tiết chế > 6 tháng

XƠ GAN MẬT NGUYÊN PHÁT (PBC)

PBC là tiến triển phá hủy không mủ viêm đường mật trong gan. Nữ giới khỏe mạnh chiếm ưu thế, độ tuổi trung bình là 50. Biểu hiện là tăng phosphatase kiềm không triệu chứng (tiền lượng tốt hơn) hoặc kèm ngứa, vàng da tiến triển, do giảm bài tiết mật, và cuối cùng là xơ gan và suy gan.

BIỂU HIỆN Lâm SÀNG

Ngứa, mệt mỏi, vàng da, u vàng mi mắt (xanthelasma), u vàng (xanthomata), loãng xương, phân mỡ, tăng sắc tố da, gan lách to, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, tăng phosphatase kiềm máu, bilirubin, cholesteroL và IgM

BỆNH LIÊN QUAN

Hội chứng Sjögren, bệnh mạch collagen, viêm tuyến giáp, viêm cầu thận, thiếu máu ác tính, toan hóa ống thận

CHUẨN ĐOÁN

Kháng thể kháng ti thể (AMA) trong 90% (trực tiếp chống lại phức hợp enzym pyruvate dehydrogenase và enzym 2-oxo-acid dehydrogenase ty thể. Sinh thiết gan là quan trọng nhất trong trường hợp AMA-âm tính PBC. Sinh thiết xác định 4 giai đoạn: Giai đoạn 1— Phá hủy đường mật gian thùy, u hạt; Giai đoạn 2— tăng sinh đường mật; Giai đoạn 3— xơ hóa; Giai đoạn 4— xơ gan.

TIỀN LƯỢNG

Tương quan với tuổi, bilirubin huyết, albumin huyết, thời gian prothrombin, phù

ĐIỀU TRỊ Xơ Gan Mật Nguyên Phát

Ursodeoxycholic acid 13–15 mg/kg/ ngày cho thấy cải thiện biểu hiện sinh hóa và mô bệnh học. Đáp ứng tốt nhất khi điều trị sớm. Cholestyramine 4 g uống cùng với bữa ăn nếu ngứa; trong trường hợp khó điều trị cân nhắc rifampin, naltrexone, thay huyết tương. Calci, vitamin D, and bisphosphonates khi loãng xương, Ghép gan trong trường hợp bệnh giai đoạn cuối

GHÉP GAN

Cân nhắc trong các trường hợp không có chống chỉ định, bệnh gan mãn tính, không thể phục hồi, tiến triển hoặc suy gan tối cấp khi không có liệu pháp thay thế sẵn có (Bảng 165-4).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH (Xem Bảng 165-5)

BẢNG 165-4 CHỈ ĐỊNH GHÉP GAN

Trẻ em	Người lớn
Hẹp đường mật	Xơ gan mật tiên phát
Viêm gan sơ sinh	Xơ gan mật thứ phát
Xơ gan bẩm sinh	Viêm xơ đường mật tiên phát
Hội chứng Alagille ^a	Viêm gan tự miễn
Bệnh Byler ^b	Bệnh Caroli ^c
Thiếu α_1 -Antitrypsin	Xơ gan chưa rõ nguyên nhân
Rối loạn chuyển hóa di truyền	Viêm gan mãn có xơ gan
Bệnh Wilson	Huyết khối tĩnh mạch gan
Bệnh Tyrosin huyết	Viêm gan tối cấp
Bệnh dự trữ glycogen	Xơ gan rượu
Bệnh liên quan đến lysosom	Viêm gan virus mãn tính
Protoporphyrin	U ác tính tế bào gan nguyên phát
Bệnh Crigler-Najjar type I	U tuyến tế bào gan
Tăng cholesterol gia đình	Gan nhiễm mỡ không do rượu
Tăng oxalat niệu nguyên phát type I	Bệnh lý đa thần kinh amyloid gia đình
Hemophilia	

^aLoạn sản động mạch gan, ống mật nghèo lân và dị tật bẩm sinh, bao gồm hẹp mạch phổi

^bỨ mật trong gan, suy gan tiến triển, chậm phát triển tinh thần và thể chất

^cGiãn đường mật trong gan

BẢNG 165-5 CHỐNG CHỈ ĐỊNH GHEP GAN

Tuyệt đối	Tương đối
Nhiễm trùng đường mật ngoài gan chưa được kiểm soát	Tuổi >70
Nhiễm trùng huyết chưa điều trị	Trước phẫu thuật gan mật rộng
Dị tật bẩm sinh không thể sửa được,	Huyết khối tĩnh mạch cửa
Lạm dụng rượu hoặc hoạt chất	Suy thận không do gan
Bệnh tim phổi nặng	U ác tính ngoài gan trước đó(trừ ung thư da không hắc tố)
U ác tính đường mật ngoài gan (trừ ung thư da không hắc tố)	Béo phì nặng
U ác tính di căn gan	Suy dinh dưỡng nặng/ hao mòn
Ung thư biểu mô đường mật	Không tuân thủ y tế
AIDS	HIV huyết thanh dương tính, thất bại kiểm soát virus HIV máu hoặc CD4 <100/ μ L
Bệnh hệ thống đe dọa tính mạng	Nhiễm trùng trong gan
	Thiếu oxy máu nặng thứ phát do shunt phải trái ở phổi (PO_2 <50 mmHg)
	Tăng áp phổi nghiêm trọng (áp lực động mạch phổi >35 mmHg)
	Rối loạn tâm thần không kiểm soát

LỰA CHỌN NGƯỜI HIỆN

Phù hợp với khả năng tương thích nhóm máu ABO và kích thước gan (kích thước mảnh ghép nhỏ hơn có thể được sử dụng đặc biệt ở trẻ em). HCV, HBV, HIV nên âm tính. Ngày càng phổ biến ghép thùy gan phải từ người lớn khỏe mạnh cho người lớn. Ghép thùy gan trái chiếm 1/3 trường hợp ghép gan ở trẻ em

ỨC CHẾ MIỄN DỊCH

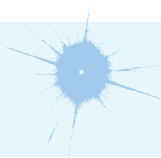
Kết hợp đa dạng các thuốc tacrolimus hoặc cyclosporine và glucocorticoids, sirolimus, mycophenolate mofetil, hoặc OKT3 (globulin đơn dòng kháng tế bào tuyến ức).

BIẾN CHỨNG SAU CẮY GHEP

Rối loạn chức năng mảnh ghép (mất chức năng nguyên phát, bị đào thải cấp hoặc mãn, thiếu máu cục bộ, huyết khối động mạch gan, tắc mật hoặc dò, bệnh tái phát); nhiễm trùng (virus, vi khuẩn, nấm, cơ hội); suy thận; rối loạn tâm thần kinh, tình trạng tim mạch không ổn định, tổn thương phổi

TỈ LỆ THÀNH CÔNG

Hiện nay , tỉ lệ sống sau 5 năm vượt quá 60%; ít hơn trong các điều kiện nhất định (như viêm van B mãn tính, ung thư biểu mô tế bào gan)



Để thảo luận chi tiết hơn, đọc bacon BR, xơ gan và biến chứng của nó, Chương 308, trang 2592; Mailliard ME, Sorrell MF: bệnh gan do rượu, Chương 307, trang 2589; Dienstag JL, Chung RT: ghép gan, Chương 310, trang 2606, cuốn “Nguyên Lý Nội Khoa Harrison”

CHƯƠNG 166

Tăng Áp Lực Tĩnh Mạch Cửa



Tăng áp lực tĩnh mạch cửa được định nghĩa là gradien áp lực tĩnh mạch gan $>5\text{mmHg}$, xuất hiện như một hậu quả của xơ gan (Chương. 165). Nguyên nhân có thể do tăng sức cản dòng chảy qua gan do ơ gan và tăng lưu lượng máu ở các tạng do giãn tĩnh mạch mạch tạng

PHÂN LOẠI (XEM BẢNG 166-1)

BẢNG 166-1 PHÂN LOẠI TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA

Trước gan

Huyết khối tĩnh mạch cửa

Huyết khối tĩnh mạch lách

Gan to (Hội chứng Banti)

Gan

Trước xoang

Sán máng

Xơ hóa gan bẩm sinh

Xoang

Xơ gan - có thể gây ra

Viêm gan rượu

Sau xoang

Tắc xoang gan (Hội chứng tắc tĩnh mạch)

Sau gan

Hội chứng Budd-Chiari

Tắc phần gan của tĩnh mạch chủ dưới (Inferior vena cava weds)

Nguyên nhân tim mạch

Bệnh lý cơ tim hạn chế

Viêm màng ngoài tim co thắt

Suy tim sung huyết nặng

HẬU QUẢ

Biến chứng chính của tăng áp lực tĩnh mạch cửa là giãn tĩnh mạch thực quản dạ dày kèm xuất huyết, cổ trướng (**Chương. 49**), tăng hoạt lách, bệnh não gan, viêm phúc mạc tự phát do vi khuẩn (**Chương. 49**), hội chứng gan thận (**Chương. 49**), ung thư biểu mô tế bào gan (**Chương. 78**).

GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN DẠ DÀY

Có tới 1/3 bệnh nhân xơ gan có giãn tĩnh mạch và 1/3 bệnh nhân có giãn tĩnh mạch chảy máu. Chảy máu là một biến chứng đe dọa tính mạng; nguy cơ chảy máu tương quan với kích thước tĩnh mạch giãn và vị trí, mức độ tăng áp lực tĩnh mạch cửa (áp lực tĩnh mạch cửa $>12\text{mmHg}$), và mức độ xơ gan, vd theo phân loại Child-pugh (xem Bảng 165-3)

CHUẨN ĐOÁN

Nội soi thực quản dạ dày: là một công cụ được lựa chọn để đánh giá xuất huyết đường tiêu hóa trên do tăng áp lực tĩnh mạch cửa hoặc nghi ngờ. Chụp mạch mạc treo và động mạch thân tạng là lựa chọn thay thế khi chảy máu ở ạt nội soi không phát hiện được và đánh giá rõ ràng tĩnh mạch cửa (cũng có thể đánh giá tĩnh mạch cửa bằng siêu âm Doppler và MRI).

ĐIỀU TRỊ

Giãn Tĩnh Mạch Thực Quản Dạ Dày

Xem **Chương. 47** Phương pháp chung điều trị chảy máu đường tiêu hóa

KIỂM SOÁT CHẢY MÁU CẤP TÍNH

Lựa chọn tiếp cận phụ thuộc vào bối cảnh lâm sàng và các công cụ sẵn có

1. Nội soi can thiệp được sử dụng là phương pháp điều trị đầu tay để kiểm soát chảy máu cấp tính. Thắt tĩnh mạch giãn qua nội soi (EVL) được sử dụng để kiểm soát chảy máu cấp tính ở $>90\%$ trường hợp. EVL ít thành công khi tĩnh mạch giãn mở rộng tới phần gần của dạ dày. Trong một vài trường hợp tiêm xơ (liệu phát xơ hóa) là phương pháp điều trị ban đầu, đặc biệt khi chảy máu ở ạt.
2. Thuốc co mạch: somatostatin hoặc octreotide (50–100 $\mu\text{g/h}$ truyền liên tục).
3. Ép bóng (ống Blakemore-Sengstaken hoặc Minnesota). Có thể được sử dụng khi nội soi không sẵn có hoặc ở bệnh nhân cần ổn định trước khi nội soi. Biến chứng — tắc họng, ngạt thở, sặc, loét thực quản. Nói chung dùng riêng trong các trường hợp chảy máu ở ạt, thất bại vasopressin và/ hoặc nội soi
4. Thông cửa chủ trong gan qua tĩnh mạch cánh (TIPS)—Thông cửa chủ bằng X quang can thiệp, dành riêng trong các trường hợp thất bại các phương pháp khác; nguy cơ bệnh lý não gan (20 -30%), tắc hoặc hẹp shunt (20-30%), nhiễm trùng

PHÒNG NGỪA CHẢY MÁU TÁI PHÁT

1. EVL nên được lặp lại đến khi loại bỏ tất cả các tĩnh mạch giãn
2. Propranolol hoặc nadolol— chọn beta không chọn lọc đóng vai trò như chất làm giảm áp lực tĩnh mạch cửa; có thể giảm nguy cơ xuất huyết giãn tĩnh mạch và tỉ lệ tử vong do xuất huyết

3. TIPS—là “cầu nối” rất hữu ích để ghép gan ở bệnh nhân điều trị nội thất bại và đang chờ ghép gan
4. Phẫu thuật nối thông cửa chủ được sử dụng ít phổ biến hơn cùng với sự ra đời của TIPS; được cân nhắc ở bệnh nhân chức năng tổng hợp của gan tốt

PHÒNG NGỪA CHẢY MÁU LẦN ĐẦU

Đối với bệnh nhân có nguy cơ giãn tĩnh mạch chảy máu, cân nhắc dự phòng EVL và/ hoặc chẹn beta không chọn lọc

BỆNH LÝ NÃO GAN

Là tình trạng thay đổi trạng thái tâm thần và khả năng nhận thức xuất hiện khi suy gan; có thể cấp tính và phục hồi hoặc mãn tính và tiến triển

BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

Lú lẫn, nói lắp, thay đổi tính cách có thể bao gồm bạo lực và hành vi không phù hợp, buồn ngủ và khó đánh thức, suy tư thể vận động (asterixis - dấu hiệu flapping tremor). Có thể tiến triển đến hôn mê; lúc đầu có đáp ứng với các kích thích, sau thì không đáp ứng

CƠ CHẾ BỆNH SINH

Các chất độc thần kinh có nguồn gốc từ ruột không được gan loại bỏ do các vòng nối và giảm khối lượng gan, đến não và gây các triệu chứng của bệnh lý não gan. Nồng độ amoniac tăng điển hình trong bệnh lý não, nhưng tương quan giữa mức độ nghiêm trọng của bệnh gan mà nồng độ amoniac thường nghèo nàn. Các chất khác có thể bao gồm chất dẫn truyền thần kinh giả và mercaptans

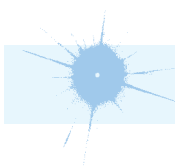
CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ

Chảy máu đường tiêu hóa, tăng ure huyết, táo bón, chế độ ăn giàu protein, nhiễm kiềm hạ kali máu, thuốc, thuốc ức chế thần kinh trung ương (vd., benzodiazepines and barbiturates), thiếu oxy, tăng cacbondioxit huyết, nhiễm trùng huyết

ĐIỀU TRỊ

Bệnh Lý Não Gan

Loại bỏ các yếu tố nguy cơ; cân bằng điện giải. Lactulose (không dung nạp disacarid) gây acid hóa đại tràng và tiêu chảy và được chất chính trong điều trị; mục tiêu là đi ngoài 2-3 lần phân mềm trong ngày. Các kháng sinh kém hấp thu thường được sử dụng ở bệnh nhân kém dung nạp với lactulose, kèm dùng xen kẽ neomycin và metronidazole để giảm các tác dụng phụ của từng chất. Rifaximin cũng được sử dụng gần đây; bổ sung kèm đôi khi hiệu quả. Ghép gan khi có chỉ định khác.



Đề thảo luận chi tiết hơn, đọc Bacon BR, xơ gan và biến chứng của nó, Chương 308, trang 2592, cuốn “Nguyên Lý Nội Khoa Harrison”

This page intentionally left blank